جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : محمد ابوالمكارم عبدالعزيز -
المحافظة : بني سويف **الحي / المدينة :** اهناسيا **العنوان :** اهناسيا
رقم البطاقة : 25202082200751 **رقم التليفون :** 01228520921 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 08-02-1952 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: محمد ابوالمكارم عبدالعزيز -
National ID: 25202082200751

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
محمد
ابو المكارم عبدالعزيز
منيل غيضان
مركز اهناسيا - بنى سويف
٢٥٢٠٢٠٨٢٢٠٠٧٥١
KR4964123


٢٥٢٠٢٠٨٢٢٠٠٧٥١
٢٠٢٤/٠٨
عامل زراعى
ذكر
مسلم
متزوج
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٨/١٠

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Date Of Submission: **Date Of MDT:** 06/21/2026 16:35:31

General GRIF MDT form

Patient Name :	Mohamoud . Abd Elaziz Ali	**Age :**	74 Y
Sex :	◉ Male ○ Female	**Comorbidity :**	Mohammed Abou Elmakarem Abdulaziz
ID No. :	7039	**Telephone :**	01110039116
Family History :	25202082200751	**Marital Status :**	○ Married ○ Divorced ○ Single
Menopausal Status :		**Reason of MDT :**	surgical
Menopausal Status :	MDT	**MDT name::**	

Medical Report

Diagnosis :
Notes :

History:	73 Y X SMOKER 20 AGO >>>>>> RT LOWE LOBE PLEURAL BASED MASS M 6X4 CM >>>>> CT2 N0 M0 >>>,>>PET CT BENIGN HFL BIOPSY ADENOCARCINOMA TTF1 PENDING >>>> MDT ON 8/1/2025 FOR IPT NACT ALIMTA CISPLATIN >> recieved 3 cycles of ALIMTA CISPLATIN
Investigations:	
Recommendations:	
MDT DECISION:	For CT CAP then Rt Lower Lobe Lung Lobectomy +/- chest wall resection & reconstruction

Signature	Hematology	Pediatric	Bone marrow transplant
د / خالد عبدالعزيز	د / احمد سيف الدين		

Name : Mohammed Abu Al-Makarem	Date : 09-12-2025 09:25
Branch : Nasrcity	Medical No. : 265965

MULTI-SLICE PET/CT EXAMINATION OF THE BODY:

Clinical History:

- A 63-year-old patient diagnosed with right lung adenocarcinoma (bronchoscopic biopsy on 19/10/2025).
- **PET/CT requested for status evaluation.**

Technique:

- For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 300 MBq of 18 F-FDG.
- MSCT performed and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis.
- Max. Variant of SUV; a Semi-quantitative analysis would be done for selected ROI.s and the normal threshold is < 2.5.

Findings:

Chest:

- **FDG avid right lung lower lobe pleural based triangular shaped consolidative area, measures approximately 6x4cm with SUVmax 10.2.**
- **Mild FDG avid right lung lower lobe posterior segment nodule noted, measures approximately 12mm with SUVmax 1.**
- No FDG avid left lung nodules or parenchymal infiltrates seen.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing related LNs seen.
- No evidence of pleural or pericardial effusion noted.

Head and Neck:

- Bilateral symmetrical FDG distribution is seen within the brain parenchyma with no abnormal metabolic activity or definite SOLs could be detected.
  (N.B: it may kindly be noted that some brain lesions not to be apparent on PET/CT and MRI is better for local assessment, if clinically warranted).
- Normal appearance of the nasopharynx, oropharynx and larynx.
- Normal appearance of thyroid and salivary glands.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing cervical LNs seen.

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Name : Mohammed Abu Al-Makarem	Date : 09-12-2025 09:25
Branch : Nasrcity	Medical No. : 265965

The Musculo-skeletal System:

- Spine degenerative changes noted.
- Normal appearance of the bony skeleton with no evidence of any abnormal avid focal tracer uptake seen.

Abdomen and Pelvis:

- **Tracer starved multiple hypodense focal hepatic lesions are seen, the largest measures 1cm, likely benign, for correlation with enhanced CT/MRI for better characterization.**
- Normal size, parenchymal tracer uptake and CT texture of both kidneys (aprt from tracer starved cysts); spleen; pancreas & both adrenals with no focal lesions or dense tracer fixing foci seen.
- No pathologically enlarged or dense tracer fixing LNs seen.
- No ascites, abdominal or pelvic collections noted.
- Normal appearance of pelvic organs.

Opinion:

- **The current study shows:**
  - **FDG avid right lung lower lobe pleural based triangular shaped consolidative area, associated with right lung nodule, as described.**
  - **Tracer starved multiple hypodense focal hepatic lesions seen, likely benign, for correlation with enhanced CT/MRI for better characterization.**
  - Rest-surveyed body lacks convincing evidence of any pathological glucose avidity.
- **Follow up PET/CT as clinically warranted would be advisable.**

Best regards,

Dr. Ahmad Abdel-Aal
Nuclear Medicine

Dr. Omnia Talaat, MD
NCI - Cairo University

NILE DIAGNOSTIC CENTER